

ITEM 297 : TUMEURS DU CORPS UTERIN

CANCER DE L'ENDOMETRE

- 4^{ème} cancer le plus fréquent de la femme, dans 80% des cas chez des **femmes ménopausées**, âge moyen = **70 ans**
- Diagnostic souvent à un stade précoce (cancer localisé) dans 70% des cas
- Histoire naturelle : - Naît le plus souvent du **fond utérin** ou d'une **corne utérine**
 - Evolution longtemps locorégionale : extension vers le col, invasion du myomètre
 - **Dissémination extra-utérine** tardive : ADP iliaques externes puis lombo-aortiques, vagin, annexes, péritoines → **métastases** rares (poumon, foie)

- | | |
|-----|--|
| Fdr | <ul style="list-style-type: none"> - Antécédents familiaux de cancer de l'endomètre - Antécédents personnels ou familiaux de cancer du colon ou de l'ovaire (HNPCC) - Antécédents personnels de cancer du sein (terrain identique) - Hyperoestrogénie absolue ou relative = cancer hormonodépendant : nulliparité, puberté précoce, ménopause tardive, obésité, diabète, THS mal conduit (oestrogènes seuls), SOPK ++, hormonothérapie au tamoxifène
→ L'HTA est souvent présente (associée à l'obésité et au diabète), mais n'est pas un facteur de risque indépendant - Régime alimentaire : riche en viandes, œufs, haricots blancs, graisses ajoutées et sucre - Lésion précancéreuse : hyperplasie endométriale atypique (dysplasie sévère) - Antécédents d'irradiation pelvienne - Facteurs protecteurs : - Contraception oestroprogestative
- Tabac |
|-----|--|

- | | | |
|-------|--|--|
| Histo | <ul style="list-style-type: none"> = Adénocarcinome (90% des cas) : tumeur épithéliale de l'endomètre - Immuno-histo-chimie : mutation p53 (type endométrioïde de haut grade), récepteurs hormonaux | |
| | Type 1 | <ul style="list-style-type: none"> = Adénocarcinome endométrioïde (80%) : forme classique - Grade histo-pronostique : - Grade 1 = cellules indifférenciées < 5% - Grade 2 = cellules indifférenciées < 50% - Grade 3 = cellules indifférenciées > 50% |
| | Type 2 | <ul style="list-style-type: none"> = Carcinome à cellule claire, carcinome mucineux, carcinome papillaire séreux ou carcinosarcome - Non hormonodépendant : plus fréquent à 50-60 ans, sans hyperoestrogénie - De moins bon pronostic |

- | | | | |
|------------|-------------------|---|---|
| Diagnostic | SF | <ul style="list-style-type: none"> - Métrorragie : spontanées, indolores, irrégulières chez une femme en péri- ou post-ménopause - Leucorrhées : purulentes et fétides (pyométrie) ou séreuse (hydrorrhée) - Forme évoluée : douleurs pelviennes, troubles urinaires, métastase | |
| | SC | <ul style="list-style-type: none"> - Antécédents, examen général (poids, TA, état cardiovasculaire), examen abdominopelvien et ganglionnaire - Examen au spéculum : origine endométriale des saignements, réalisation de biopsie à la pipelle de Cornier - Touchers pelviens : - Utérus classiquement gros (inconstant), globuleux, de consistance molle - Extension extra-utérine, aux paramètres (induration, rétraction utérine) ou rectale | |
| | PC | Echographie ± hystéro-sonographie | <ul style="list-style-type: none"> - Augmentation anormale de l'épaisseur de l'endomètre > 5 mm après la ménopause
→ Une épaisseur endométriale fine < 4 mm rend la probabilité de cancer de l'endomètre faible - Appréciation du degré d'infiltration du myomètre - Doppler : vascularisation anormale (néovaisseaux) |
| | | Biopsie d'endomètre | <ul style="list-style-type: none"> = Indispensable (même si endomètre normal à l'échographie chez la femme ménopausée) : diagnostic de certitude, type histologique et grade - Biopsie d'endomètre à la canule de Novak ou à la pipelle de Cornier : sans anesthésie, en ambulatoire, à l'aveugle (parfois non réalisable) → seulement une valeur prédictive positive - Hystéroscopie-curetage sous AG, si : - Pipelle impossible - Persistance de saignement avec endomètre fin < 4 mm - Pipelle négative avec endomètre épaissi > 4 mm |
| | Bilan d'extension | <ul style="list-style-type: none"> - IRM pelvienne et lombo-aortique injectée = examen de référence : profondeur d'invasion myométriale, recherche d'une atteinte vésicale, rectale ou paramétriale, ADP iliaque et lombo-aortique suspecte - Scanner thoraco-abdomino-pelvien : indiqué si stade III ou N+ ou type 2 histologique - PET-scanner : non systématique, discuté en cas de stade III (T3, N1) et IV (T4, M1) - Dosage du CA 125 : discuté en cas de suspicion d'extension régionale, d'atteinte ovarienne ou de type 2 histo - Associés : - Bilan d'opérabilité
- Mammographie bilatérale de dépistage systématique (terrain à risque) | |

Classification FIGO	Stade I	Survie à 5 ans 85%	= Limité au corps utérin (± glandes cervicales) : sans atteinte du col utérin - IA = envahissement du myomètre < 50% - IB = envahissement du myomètre ≥ 50%
	Stade II	66%	= Atteinte du col utérin sans atteinte extra-utérine associée
	Stade III	44%	= Extension extra-utérine : - IIIA = séreuse du corps utérin et/ou annexes - IIIB = vagin et/ou paramètre - IIIC = envahissement ganglionnaire pelvien (c1) ou para-aortique (c2)
	Stade IV	15%	- IVA : atteinte de la muqueuse vésicale et/ou rectale - IVB : ADP ganglionnaire inguinale et/ou MT à distance
Pronostic	Facteurs pronostiques	- Age élevé, comorbidités - Tumeur : stade FIGO, type (type 1 de bon pronostic, type 2 de mauvais pronostic) et grade - Degré d'envahissement du myomètre - Envahissement ganglionnaire - Cytologie péritonéale positive (risque x 3 de récurrence extra-pelvienne)	
	Groupes pronostiques du stade I	- Bas risque : type 1 stade IA grade 1 ou 2 - Risque intermédiaire : type 1 stade IA grade 3 ou stade IB ou II grade 1 ou 2 - Risque élevé : type 1 stade IB ou II grade 3 ou embolies lymphatiques ou tous type 2	
TTT	Stade I Type 1	- Risque bas : hystérectomie totale avec annexectomie sans traitement adjuvant - Risque intermédiaire : hystérectomie + curage pelvien + curiethérapie post-opératoire - Risque élevé : hystérectomie totale avec annexectomie + curage lombo-aortique et iliaque commun ± pelvien + radiothérapie externe ± curiethérapie	
	Stade I Type 2	- Chirurgie : hystérectomie totale avec annexectomie + curage pelvien et lombo-aortique + cytologie et biopsies péritonéales + omentectomie infra-colique - Radiothérapie post-opératoire ± curithérapie ± chimiothérapie adjuvante	
	Stade II	- Chirurgie : hystérectomie totale (± élargie) + curage pelvien ± lombo-aortique - Radiothérapie + curithérapie post-opératoire + chimiothérapie adjuvante si type 2	
	Stade III	- IIIA : - Hystérectomie totale avec annexectomie + curage pelvien et lombo-aortique + cytologie péritonéale + omentectomie infra-colique - Radiothérapie et chimiothérapie post-opératoire - IIIB : radiothérapie exclusive (radiothérapie externe + curithérapie) ± curage lombo-aortique pré-thérapeutique ± chimiothérapie adjuvante → chirurgie si réponse complète - IIIC : curage lombo-aortique + radiothérapie externe + curithérapie ± chimiothérapie adjuvante	
	Stade IV	- IVA : - Radiothérapie exclusive (radiothérapie externe + curithérapie) ± chimiothérapie - Chirurgie (exentération pelvienne) si échec de l'irradiation - IVB : - Chirurgie de cytoréduction complète si carcinose péritonéale résécable sans MT à distance - Chimiothérapie + hormonothérapie si RH+ + radiothérapie externe	
	Mesures associées	- Traitement hormonal substitutif non contre-indiqué : seulement oestrogénique < 50 ans en cas de ménopause invalidante induite par l'ovariectomie	
	Complication	- Curithérapie/radiothérapie : cystite radique, rectite radique, sténose urétérale post-radique, dyspareunie, sténose de l'intestin grêle (si hystérectomie)	
HNPCC	Surveillance	Surveillance uniquement clinique (en l'absence de signe d'appel) : recherche d'une récurrence et des effets 2 nd tardifs des traitement et prévention/dépistage d'un 2 nd cancer - Tous les 4-6 mois pendant les 3 premières années puis annuellement pour les stades I et II - Tous les 4-6 mois durant les 5 premières années puis annuellement pour les stades III et IV	
	- Phénotypage MSI (instabilité des microsatellites) sur la pièce tumorale si : - Femme jeune < 50 ans - Antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal ou du spectre HNPCC - Si phénotype MSI positif : recherche d'une mutation MMR (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) sur prélèvement sanguin → Phénotype MSI non spécifique : 25 à 40% des cancers de l'endomètre sont MSI+, pour 2 à 5% de syndrome de Lynch		

CANCER DE L'ENDOMETRE								
Stade			Atteinte	CHIRURGIE		RADIOTHERAPIE		CHIMIO-THERAPIE
				Tumeur	Curage	Radiothérapie externe	Curie-thérapie	
Stade I	Type 1	Risque bas	IA (< 50% myomètre) de grade 1 (< 5% cellules indifférenciées) ou 2 (< 50%)	Oui				
		Risque moyen	IA de grade 3 (> 50%) IB (> 50% myomètre) de grade 1 ou 2	Oui	Oui		±	
		Risque haut	IB de grade 3 ou embolie	Oui	Oui	Oui	±	
	Type 2	ADK non endométrioïde : à cellule claire, mucineux, papillaire séreux, carcinosarcome		Oui	Oui	Oui	±	±
Stade II		Atteinte du col utérin		Oui	Oui	Oui	Oui	Si type 2
Stade III	IIIA	Séreuse du corps utérin et/ou annexe		Oui	Oui	Oui		Oui
	IIIB	Vagin et/ou paramètre		Si réponse complète	±	Oui	Oui	±
	IIIC	ADP pelvienne ou para-aortique			Oui	Oui	Oui	±
Stade IV	IVA	Vésicale et/ou rectale		Si échec		Oui	Oui	±
	IVB	ADP inguinale et/ou MT				Oui		Oui Hormono-thérapie si RH+

FIBROME UTERIN

Fibrome utérin (= fibromyome ou myome) = tumeur bénigne bien limitée, encapsulée, vascularisée, développée à partir du muscle utérin et constituée de tissu musculaire lisse et de tissu fibreux (léiomyome) : fréquent = **20%** des femmes > 35 ans
- Souvent multiples (70%) = **utérus polymyomateux**

FdR

- = **Rôle favorisant des oestrogènes** : ↗ de volume lors de la grossesse, la péri-ménopause ou la prise d'oestroprogestatif
- Selon l'activité génitale : aucun fibrome avant la puberté, ↘ volume après la ménopause
- **Hyperplasie endométriale** souvent associée (du fait de l'hyperoestrogénie) : à l'origine des **ménorragies**
- Autres facteurs de risques : antécédents familiaux, origine d'Afrique Noire

Localisation	Fibrome intra-cavitaire		= Siège à l'intérieur de la cavité utérine : pédiculé , voire accouché par le col utérin - Plutôt métrorragies d'origine mécanique
	Fibrome sous-muqueux		= Développé dans l'endomètre : fait saillit dans la cavité utérine, à base d'implantation large - Ménorragie par hyperplasie endométriale et métrorragie par abrasion de l'endomètre
	Fibrome interstitiel ou intra-mural		= Dans l'épaisseur du myomètre : aspect d'utérus bosselé - Plutôt ménorragies par hyperplasie endométriale associée
	Fibrome sous-séreux		= Développé à l'extérieur de l'utérus : base d'implantation large (sessile) ou pédiculé - Souvent asymptomatique avec développement à bas bruit - Torsion possible autour du pédicule en cas de fibrome pédiculé
	Classification FIGO	Sous-muqueux	- 0 : pédiculé intra-cavitaire - 1 : > 50% intra-cavitaire - 2 : < 50% intra-cavitaire - 2-5 : sous-muqueux < 50% et sous-séreux
		Interstitiel	- 3 : contact avec l'endomètre - 4 : intra-mural
		Sous-séreux	- 5 : sessile avec > 50% intra-mural - 6 : sessile avec < 50% intra-mural - 7 : pédiculé sous-séreux
		Autre	- 8 : cervicaux ectopiques



Diagnostic	SF	- Le plus souvent asymptomatique, de découverte fortuite : dans 50% des cas - Troubles hémorragiques : - Ménorragie (règles abondantes prolongées) due à l'hyperplasie endométriale - Métrorragie (plus rares) : rarement isolées, souvent ménométrorragies - Sensation de pesanteur pelvienne , ↗ progressive et indolore du volume de l'abdomen - Dysménorrhée : fibrome du col ou de l'isthme gênant l'évacuation du flux menstruel - Compression de voisinage : signes urinaires (pollakiurie, dysurie), constipation
		- TV : - Tumeur régulière, de consistance ferme, non élastique, indolore, lisse ou bosselée - Solidaire de l'utérus (sauf dans certains cas de fibromes sous-séreux pédiculés)
	PC	- NFS : recherche d' anémie associée
		Echographie pelvienne - Confirmation diagnostique : tumeur solide, légèrement hypoéchogène, ↗ du volume utérin, déformation des contours utérins, déviation de la ligne de vacuité utérine - Recherche d' hypertrophie endométriale
		Hystéroscopie diagnostique - Diagnostic des fibromes endo-cavitaires et sous-muqueux - Curetage-biopsie de l'endomètre si aspect suspect ou métrorragies péri-ménopausiques
		IRM pelvien - Non systématique : indiquée si masse > 10 cm, nombre de fibromes ≥ 5 ou toute masse complexe ou indéterminée échographique, ou avant traitement chirurgical ou embolisation

Complications	Complication hémorragique	= Les plus fréquentes : - Hémorragie génitale (surtout fibrome sous-muqueux), favorisée par un DIU - Anémie ferriprive souvent associée - Exceptionnellement : hémorragie intra-péritonéale (rupture d'une grosse veine superficielle)
	Compression lente	- Vessie = fibrome antérieur : dysurie, pollakiurie - Rectum : constipation, pesanteur anale - Uretere = fibrome inclus dans le ligament large (rare) : urétéro-hydronéphrose, colique néphrétique - Compression des veines iliaques (exceptionnelle) : OMI, TVP des MI - Compression nerveuse : sciatalgie (face postérieure de cuisse), névralgie obturatrice (face interne)

Complications	= Ischémie du fibrome due à une mauvaise vascularisation : fréquent, favorisé par la grossesse	
	Nécrobose aseptique	Dg - Douleur pelvienne intense ± métrorragie de sang noirâtre - Syndrome toxi-infectieux : fièvre (38-39°), pâleur - Fibrome augmenté de volume, ramolli, très douloureux - Echo : image « en cocarde » avec zone centrale de nécrose entourée d'œdème
		TTT - Hospitalisation : repos au lit, vessie de glace, antalgique - Antalgiques + AINS (ou corticothérapie si grossesse) - Amoxicilline prophylactique discutée (risque de surinfection)
	Autre complication douloureuse	- Torsion de fibrome sous-séreux pédiculé (DD rare de la torsion d'annexe) : douleur abdominale violente, d'installation brutale, avec défense abdominale ± vomissements, perte de connaissance - Accouchement par le col d'un fibrome pédiculé sous-muqueux : coliques expulsives
	Complication infectieuse	= Très rare : surtout en cas de fibrome intra-cavitaire accouché par le col - Coliques expulsives, métrorragies, leucorrhée malodorante, syndrome infectieux
	Dégénérescence	- Dégénérescence maligne en sarcome : exceptionnelle (discutée)
	Infertilité	→ Diagnostic d'élimination lors de la découverte d'un fibrome dans un bilan d'infertilité - Indication chirurgicale en cas de fibrome intra-cavitaire ou sous-muqueux déformant la cavité utérine
TTT	Grossesse	- Risque de nécrobose aseptique - Risque d'accouchement prématuré - Présentation dystocique → Toute geste chirurgical (myomectomie) est contre-indiqué lors de la grossesse ou d'une césarienne
	→ L'évolution spontanée d'un fibrome est imprévisible : régression habituelle après la ménopause - Supplémentation martiale en cas d'anémie ferriprive - Aucune contre-indication à la contraception orale oestroprogestative ou au traitement hormonal substitutif - Contre-indication au DIU : seulement en cas de fibrome sous-muqueux volumineux ou utérus polymyomateux	
	Abstention	- Fibrome asymptomatique < 10 cm : aucune indication de traitement ou de surveillance échographique
	TTT médical	Progestatif = Action atrophiante sur l'hyperplasie de l'endomètre, sans effet sur le fibrome - Indication : troubles hémorragiques associés aux fibromes par hyperplasie de l'endomètre - Macro-progestatif de J15 à J25 (ou J5-J25 si effet contraceptif voulu), sur une durée de 6 mois : norpregnane (Lutényl®), promegestone (Surgestone®), Lutéran® - DIU au lévonorgestrel (Miréna®) : utilisable en l'absence de myome sous-muqueux
		Agoniste de la LHRH = Decapeptyl® LP 1 injection/mois : castration médicale réversible → ↓ volume du fibrome - Indication en pré-opératoire pour une durée limitée (2 à 3 mois) en cas d'anémie sévère avant hystérectomie ou volume trop important (facilite ou modifie la technique opératoire)
		Ulipristal d'acétate = Esmya® = modulateur sélectif des récepteurs à la progestérone → ↓ taille des fibromes - Indication pendant 3 mois maximum en pré-opératoire, par voie orale
	TTT chirurgical	Indication - Ménorragies fonctionnelles résistantes au traitement médical - Fibrome compliqué : douleurs pelviennes (nécrobose, torsion), compression, infertilité
		TTT conservateur - Myomectomie par coelioscopie ou laparotomie : en cas de fibrome volumineux unique - Hystéroscopie opératoire : en cas de fibrome endo-cavitaire et sous-muqueux < 4 cm
		TTT radical - Hystérectomie totale : inter-annexielle (femme non ménopausée) ou avec annexectomie bilatérale (> 50 ans), par voie vaginale, coelioscopique ou laparotomie
		- Examen anatomo-pathologique systématique - Complication: hémorragie, thrombo-embolique, récurrence anatomique si myomectomie, adhérences pelviennes
	Myolyse	Embolisation des artères utérines - Indication thérapeutique pour les fibromes symptomatiques chez la femme ne désirant pas de grossesse : taux de succès à de 80 à 90% 5 ans - Avantages : conservateur, ↓ la taille des fibromes, possible en préopératoire - Complications : douleur post-embolisation, infection, insuffisance ovarienne prématurée (embolisation accidentelle de la vascularisation ovarienne)
		Thermo-coagulation = Ultrasons, HIFU, radiofréquence, coagulation ou cryothérapie : neutralisation du fibrome sans disparition, avec un taux de succès de 50 à 70% à 5 ans